

HITNI PREGLED

Protokol broj: 2026031630

MULALIĆ NEDŽAD

Rođen: 20.06.1933, Adresa: PLETENCI 4/1, 51000 RIJEKA

Dijagnoza: E87.6 - Hipokalemija

MBOO: 119931965

Datum pregleda: 31.07.2026

Vrijeme pregleda : 09:07 sati/min.

Parametri

Vrijeme	RR mmHg	Puls /min	Tax °C	Trect °C	Diureza ml	SpO2	GUK mmol/l	f disanja /min
09:04	90/60	120	37,9			90		18
11:28	115/60							

Anamneza i fizikalni status 93-godišnji pacijent dolazi privatnim sanitetom na OHBP po pozivu djelatnika saniteta da je pacijent lošeg aspekta. Inače bio upućen na pregled gastroenterologa s C2 uputnicom. U pratnji sin. Navode da pacijent ima proljevaste stolice unazad 5 mjeseci, stolica svakodnevna, bez krvi i sluzi, do 5 dnevno. Jučer subfebrilan do 37.7°C, bez zimica i tresavica. Također, saznajem da je pacijent imao bolove u abdomenu zadnji puta 23.7.2026. kad je od strane HMP predložen prijevoz u bolnicu koji je odbio - tada bila lokalizirana u L hemiabdomenu. Izgubio na tjelesnoj težini 15 kg unazad 5 mjeseci. Bez mučnine i povraćanje. Nije imao vrtoglavice, omaglice, krize svijesti. Bez boli u prsima, palpitacija ili dispneje. Slabo pokretan od ranije, žali se na umor i iscrpljenost. U prilogu i nalaz u kojem se navodi CEA<1000; C19-9 <1.5; na MR-u 29.3.2025. znakovi peritonealne karcinomatose. Drugih informacija ne saznajem. Apetit varira, gubi na TT; mokrenje u pelenu, koncentriran urin; stolica opisana ranije. Nije konzumira alkohol niti pušio.

Dosadašnje bolesti: M53.2 Instabilitet uslijed kompresivne frakture L4 kralješka; M48.5 Prelomljen (kolabiran) kralježak, nesvrstan drugamo; G55.3 Kompresija živčanog korijena i pleksusa kod ostalih dorzopatija (M45-M46+, M48.-, M53-M54+); 24.05.2026. Vertebrozyntesis TP percutanea L3 et L5 bilat. sec Vyper; 10.7.2015. Osteosinteza pločicom i vijcima (LCP - VA); Stp fixatio vert. L3/L5; Arterijska hipertenzija, Hiperplazija prostate
Terapija: Massido
Alergije na lijekove: NEGIRA

Fizikalni status:

Osrednjeg općeg stanja, svjestan, orijentiran u sva tri pravca, slabo pokretan, afebrilan, eupnoičan u mirovanju, koža i vidljive sluznice dobro prokrvljene.
Pluća: auskultatorno uredan šum disanja.
Srce: akcija ritmična, tonovi jasni, šuma ne čujem.
Abdomen: stijenka u razini grudnog koša, mekana, elastična, bezbolna na palpaciju, jetru i slezenu ne palpiram, lumbalna sukusija negativna, peristaltika čujna.
Ekstremiteti: simetrični, tjestasti edemi u području maleola.

Ordinirana terapija

Terapija	Vrijeme
40 mEq KCl u 500 ml 0.9% NaCl iv.	
levofloksacin 5mg/ml, 100 ml iv.	

Postupci EKG: I. el. os; SR f 118/min

ABS (venska krv) - pH - ak 7.49, pCO₂ - ak 4.8 kPa, pO₂ - ak 3.6 kPa, Akt.HCO₃-a 26.7 mmol/L, tCO₂ - ak 27.8 mmol/L, SBE - ak 3.7 mmol/L, sO₂ - ak 45.5 %, tHb POCT 105 g/L, Hct POCT 0.324 L/L, MetHb - ak 1.0 %, COHb - ak 1.2 %, Ohb - ak 44.5 %, GUK - ak 9.3 mmol/L, Na - ak 134 mmol/L, K - ak 2.8 mmol/L, Cl - ak 110 mmol/L, Ca++ - ak 1.05 mmol/L, Lact - ak 4.4 mmol/L

Lab: E 3.56 [1e12]/L, Hgb 101 g/L, Hct 0.314 L/L, MCV 88.2 fL, MCH 28.4 pg, MCHC 322 g/L, RDW 16.3 %, Trc 186 [1e9]/L, MPV 9.3 fL, Lkc 13.4 [1e9]/L, GLU (s) 8.9 mmol/L, UREA 13.4 mmol/L, KREA 120 μmol/L, eGFR CKD 45 mL/min/1.73m², Na 140 mmol/L, K (s) 3.0 mmol/L, Cl 102 mmol/L, TBIL 14 μmol/L, BIL-K 4 μmol/L, BIL -NK 10 μmol/L, AST 40 U/L, ALT 15 U/L, ALP 140 U/L, GGT 12 U/L, AMY 37 U/L, LIP 33 U/L, CRP 148.8 mg/L, Izgled (u) / /, Boja (u) / /, Specifična težina / kg/L, pH (u) / pH j., Leukocitna ester / /, Proteini (u) / /, Glu-urin / /, Ketoni / /, Urobilinogen (u) / /, Nitriti (u) / /, Bilirubin (u) / /, Eritrociti/hemog / /, Sed. /

TnI; NT-proBNP: TnI 25.1 ng/L, NTproBNP 3600 ng/L

URIN: Izgled (u) Mutan /, Boja (u) Tamno žut /, Specifična težina 1.015 kg/L, pH (u) 5.0
pH j., Leukocitna ester +++ /, Proteini (u) neg /,
Glu-urin norm /, Ketoni neg /, Urobilinogen (u) norm /, Nitriti (u) neg /, Bilirubin (u)
neg /, Eritrociti/hemog + /, Eritrociti 4 [1e6]/L,
Leukociti (u) 4069 [1e6]/L, Bakterije (u) 4462 [1e6]/L

Koagulogram: PV 0.93 udio, INR 1.0, APTV 18.8 s, APTV-om 0.7, Fib 2.9 g/L

AP RADIOGRAM GRUDNIH ORGANA

U projekciji lijevog plućnog krila vidi se opsežniji areal inhomogenog zasjenjenja
vjerojatno upalne etiologije.

Moguće je i razliveni lijevostrani pleuralni izljev.

RADIOGRAM ABDOMENA LEŽEĆI NA LIJEVOM BOKU

Meteorizam vijuga uz crijevni sadržaj i poneki kraći aerolikvidni nivo.
Bez znakova za pneumoperitoneum.

UK/HK: u izradi

Mini respiratorni panel u izradi.

Epikriza Po dolasku na OHBP postavljen na neinvazivni monitoring vitalnih vitalnih
funkcija - bez poremećaja ritma, urednih vitalnih parametara.

Postavljen urinski kateter Ch18 po čemu se dobije 150 ml bistrog urina.

Završna dijagnoza

K59.1 proljev (dijareja)

Ostale dijagnoze

E87.6 Hipokalemija

N39.0 Infekcija urinarnoga trakta, lokacija neoznačena

J18.9 Pneumonija uz lijevostran pl. izljev

Preporuke Pacijent se upućuje na pregled interniste i infektologa.

Mrsc. Medita Smailj, dr.med.
Specijalist hitne medicine
0185477

Specijalist
Mr.sc. Medjit Smailj, dr.med.
specijalist hitne medicine
(0185477)

Učesnik:
Alojzije Košić, dr.med.
Specijalizant onkologije, radioterapije
(9130764)

Datum izdavanja: 31.07.2026. 11:32

NAPOMENA: Umjesto propisanog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda
učinkovitosti u odgovarajuće jednakim dozama.

Sadržaj ispisa medicinske dokumentacije, potpisi i titule liječnika istovjetni su sadržaju na dan izrade dokumentacije.
Zaglavlje dokumenta sadrži podatke o sistematizaciji organizacijskih jedinica i nositeljima funkcija na dan ispisa dokumenta.